

Urgences obstétricales

I. Pré-éclampsie – Eclampsie

1. Définitions

- **HTA gravidique (HTAG) : PAS $\geq$ 140mmHg et/ou la PAD $\geq$ 90mmHg (survenant après 20SA et disparaissant avant le 42^e jour post partum)**
- **Pré éclampsie : HTAG + Protéinurie $>$ 0.3 g/24h (après 20SA et disparaissant avant la 6^e semaine du post partum)**
- **Pré éclampsie sévère : critères de gravité :**
 - Douleurs épigastriques, nausées, vomissements
 - Céphalées persistantes, hyper réflexivité ostéo-tendineuse
 - Protéinurie $>$ 3g/j
 - Créatininémie $>$ 100 Umol/l
 - Oligurie $<$ 20ml/h
 - Hémolyse
 - ASAT $>$ 3fois la normale
 - Thrombopénie $<$ 100 000/mm³

HELLP syndrome : hémolyse, transaminases élevées et LDH élevées et une thrombopénie
Eclampsie : convulsions, signes neurologiques

2. Les manifestations neurologiques :

- ⇒ Hémiparésie
- ⇒ Hémiplégie
- ⇒ Monoparésie
- ⇒ Paralysie faciale
- ⇒ Cécité corticale
- ⇒ Psychose
- ⇒ Troubles de conscience

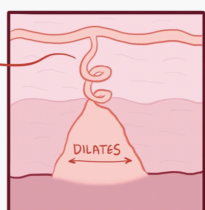
3. Physiopathologie de la pré-éclampsie :

Pathogénie de l'éclampsie :
encéphalopathie hypertensive et/ou vasospasme ?

Edème cérébral : Lésion la plus fréquente ++, occipitale ++

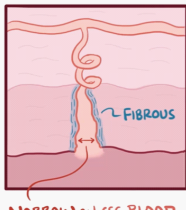
DEVELOPMENT of an ABNORMAL PLACENTA

NORMAL



DEVELOPMENT of an ABNORMAL PLACENTA

PREECLAMPSIA



POORLY PERFUSED PLACENTA

- INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION
- FETAL DEATH
- RELEASES PRO-INFLAMMATORY !



LOCAL VASOSPASM

KIDNEY

RETINA

LIVER

RIGHT UPPER QUADRANT PAIN (EPIGASTRIC)

*** INJURY & SWELLING**

*** ELEVATION of LIVER ENZYMES**

*** STRETCHES CAPSULE**

*** BURRED VISION**

*** FLASHING LIGHTS**

*** SCOTOMA**

LOW Oliguria

PROTEINURIA

Sign of GLOMERULAR DAMAGE

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

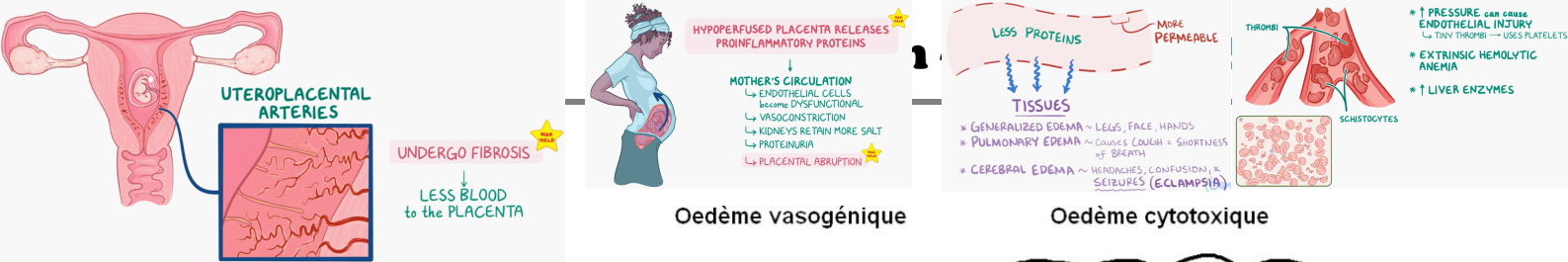
HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

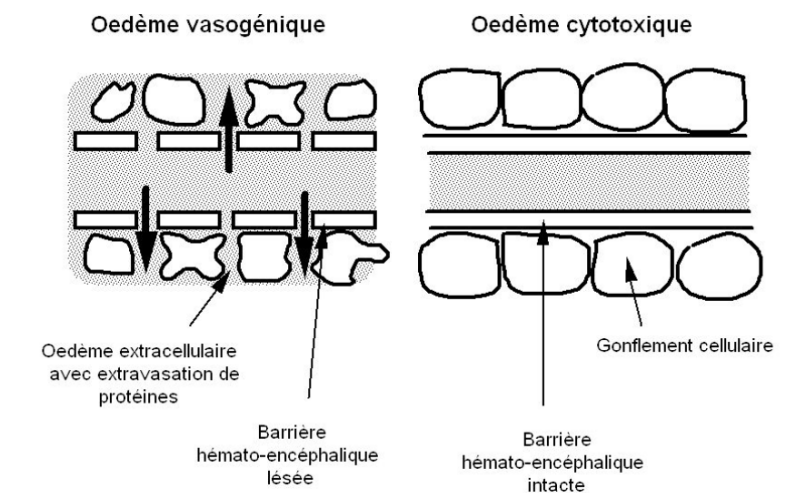
HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME

HELLP SYNDROME



- Ischémie
- Hémorragie
- Thrombose veineuse cérébrale

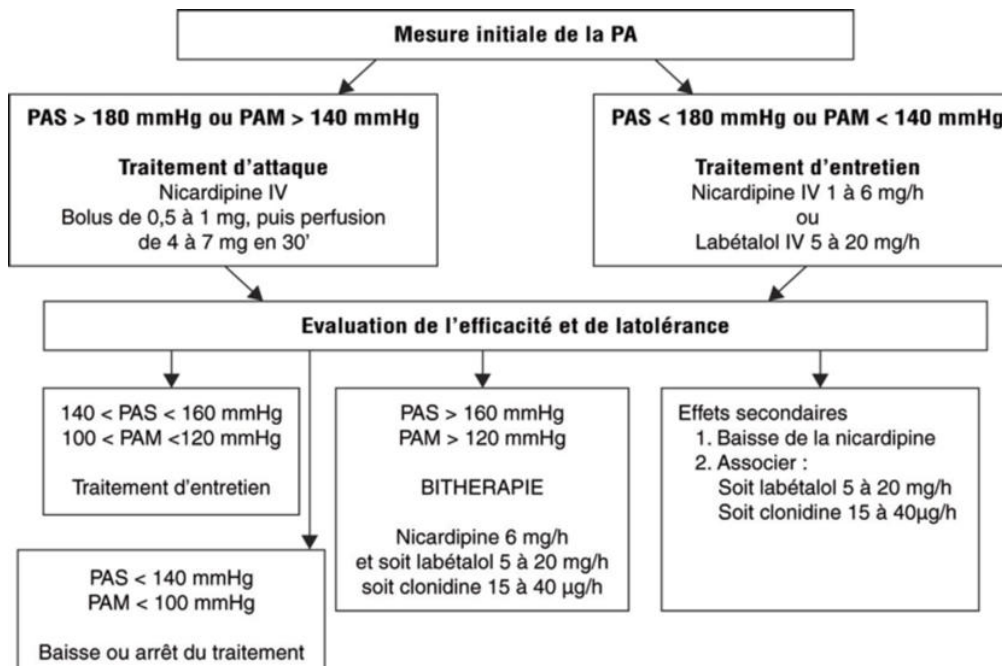


❖ Antihypertenseurs :

- Inhibiteurs calciques (nicardipine)
- Alphaméthyl dopa (Aldomet®)
- Bêtabloquant (labétalol)
- Clonidine (Catapressan®)
- Dihydralazine (Nepressol®) ??



	Bolus	Entretien
Dihydralazine	6mg	2-4mg/h
labetalol (Trandate®)	1mg/Kg en IVL	0,1mg/Kg/h
Nicardipine	En titration : 0,5 à 1mg	2-4mg/h
Clonidine		0,06 – 0,3 mg/h



Agent	Mécanisme d'action	Indications	Contre-indications
Labetalol	Bêta-bloquant	1ère ligne de traitement de l'hypertension pendant la grossesse	Insuffisance cardiaque, bradycardie, hypotension
Nicardipine	Inhibiteur calcique	2ème ligne de traitement de l'hypertension pendant la grossesse	Insuffisance cardiaque, bradycardie, hypotension
Clonidine	Agoniste alpha-2	3ème ligne de traitement de l'hypertension pendant la grossesse	Insuffisance cardiaque, bradycardie, hypotension

4. Les principes de la prise en charge de l'éclampsie :

- ✓ Contrôle de la pression artérielle
- ✓ Normaliser la volémie



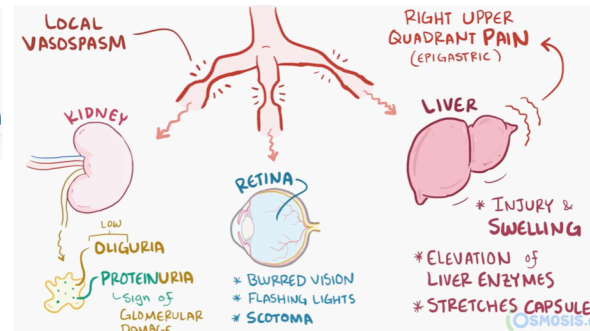
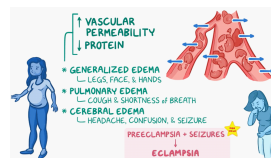
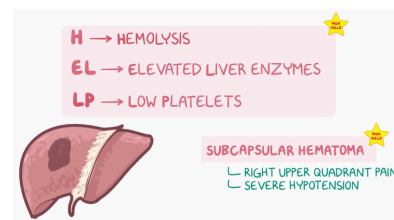
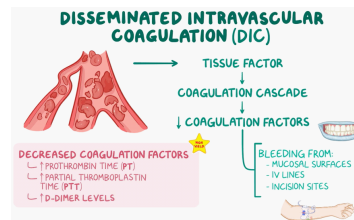
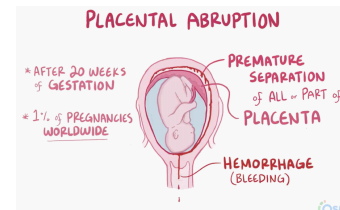
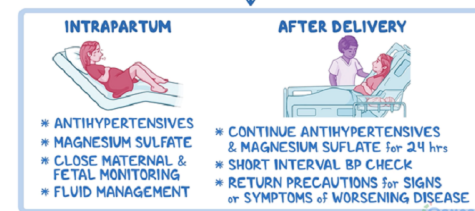
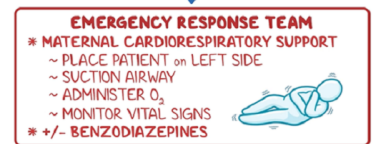
- ✓ Traitement de l'œdème cérébral et de l'HTIC
- ✓ Arrêter les convulsions +++
- ✓ Corriger les anomalies de l'hémostase
- ✓ Interrompre la grossesse

5. Convulsions :

- Benzodiazépines
- Sulfate de magnésium +++
 - Prévention primaire et secondaire (la récursive)
 - 4g en 20min
 - 1g/h en IVSE pdt 24h (IVSE = intra-veineuse par seringue électrique)
- Intubation orotrachéale
- Sédation
- Monitoring

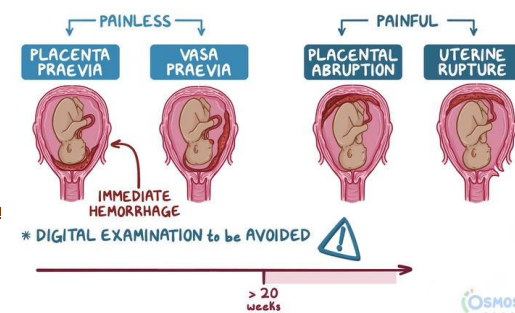
6. Complications :

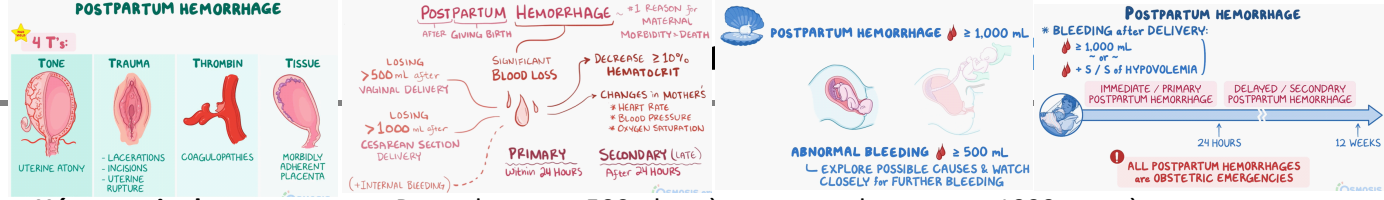
- Eclampsie
- Hématome rétroplacentaire
- Complications hépatiques :
 - Hématome sous capsulaire du foie
 - HELLP syndrome
 - Stéatose hépatique aigue gravidique
- Insuffisance rénale aigue
- Accident vasculaire cérébral
- Œdème aigu du poumon
- Troubles de l'hémostase
- Complications ophtalmologiques :
 - Cécité centrale
 - Troubles oculaires persistants
- Complications fœtales :
 - Hypotrophie
 - Prématurité
 - MFIU



II. Hémorragie en obstétrique

- **Choc hémorragique** : insuffisance circulatoire aigue, en rapport avec déperdition sanguine importante, entraînant une inadéquation entre les apports et les besoins en oxygène. Le résultat est une hypoxie tissulaire et souffrance d'organes
- **Hémorragie du pré-partum** :
 - Hématome rétro placentaire (HRP) : décollement prématuré du placenta survenant avant la délivrance
 - Placenta praevia : implantation anormale du placenta qui se trouve en avant de la présentation fœtale





• Hémorragie du post partum : Perte de sang > 500ml après un accouchement ou 1000cc après césarienne

- Atonie utérine+++
- Rétention placentaire (révision utérine)
- Lésions de la filière génitale
- Inversion utérine
- Troubles de l'hémostase congénitaux ou acquis

Critères de gravité d'une Hgrie du post-partum :

• Prise en charge des hémorragies obstétricales :

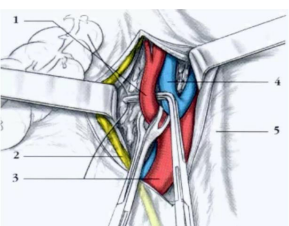
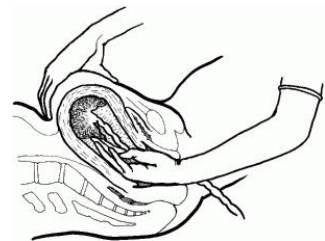
- Mise en condition et maintien d'une volémie efficace
 - Monitoring
 - 2 voies veineuses (14-16G)
 - Accélérateur de perfusion avec système de réchauffement
 - Appareil (HTC-HB) : Hemocue®
 - Remplissage vasculaire :
 - Colloïdes :
 - ⇒ HEA 15-20ml/kg+++
 - ⇒ Albumine 4%
 - ⇒ Gélamines +/-
 - Cristalloïdes : sérum salé..

- Traitement de l'anémie et des troubles de la coagulation :

- Produits sanguins et hémostatiques
 - ⇒ Culots globulaires
 - ⇒ PFC (viro-inactivé)
 - ⇒ Concentrés plaquettaires
 - ⇒ Acide tranexamique (Exacyl)= Antifibrinolytique
 - ⇒ Facteur VII activé recombinant (rFVII a)
 - ⇒ Fibrinogène
- Objectifs :
 - ⇒ Hb : 8-10g/100ml
 - ⇒ TP ε 50%
 - ⇒ PQ ε 50 000 mm³
 - ⇒ Fibrinogène > 1g/l

- Maintien d'une oxygénation efficace : masque, VA et AG
- Antibiothérapie : choc hémorragique pendant 48h → amoxicilline + inhibiteur des beta lactamases
- Drogues cardio-vasoactives
- Prise en charge anesthésique
- Prise en charge obstétricale :

- Césarienne
- Révision utérine externe ou interne
- Utéro toniques : ocytocine (syntocinon)
 - 5-20UI en perfusion
 - 1^{ère} intention
- Prostaglandines (sulprostone=Naladore) :
 - Traitement de référence pour des atonies résistantes à l'ocytocine
 - 1^{ère} ampoule de 500 µg en 60min
 - puis une 2^{ème} ampoule de 500 µg sur 5h
- Embolisation artérielle
- Ligature vasculaire, hystérectomie





CAT devant une hémorragie du PP

Définition : saignement > 500ml après voie basse
> 100ml après césarienne
Aviser les chefs (obstétricien + réanimateur)

Ex Sous Valves
Révision utérine

1^{ère} étape :

1. 2 VV : sérum salé
2. bilan ; GS – NFS – hémostase
3. Syntocinon : 10UI IV lente
10UI en perfusion
4. Mathergin : 2 amp en IM / 8h
5. Packing

2^{ème} étape : (après 30')

1. Macromolécule
2. Transfusion sanguine : CG – PFC – CP
3. Analogues des prostaglandines
4. Vasoconstricteurs : adrénaline 1mg/h

3^{ème} étape : (après 30')

1. Ligature vasculaire
2. Embolisation artérielle

NovoSeven
90µg/kg
+/- 2^{ème} dose

Hystérectomie d'hémostase

